

25.1.1.3	das individuelle orale Erkrankungsrisiko und das Risiko für das Fortschreiten oraler Erkrankungen auf Grund bestehender Allgemeinerkrankungen einschätzen und bei der zahnärztlichen Behandlung berücksichtigen.				3b		Diabetes mellitus, Demenz, Schlaganfall (i.S. motorischer und kognitiver Defizite)	5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.1.1.4	Änderungen in den Ernährungsgewohnheiten älterer Menschen sowie auch Menschen mit Behinderungen beschreiben und deren Auswirkungen auf die Mundgesundheit einordnen.				2			5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.1.1.5	alternative enterale und parenterale Ernährung definieren.				1			5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.1.1.6	Defizite im Ernährungszustand von älteren autarken oder pflegebedürftigen Patientinnen/Patienten identifizieren und in die Behandlungsplanung einbeziehen.				3b			5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.1.1.7	Befunde im Rahmen der allgemeinmedizinischen Routinediagnostik bewerten und ihren Einfluss auf orale Erkrankungen oder deren Therapie einschätzen.				3b		INR/Quick, Blutbild	5; 6; 7; 9; 11; 14 19; 20; 21 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h;		
25.1.1.8	Befunde im Rahmen der Routinediagnostik, die Verdachtsdiagnosen außerhalb der Zahnmedizin nach sich ziehen, erkennen, bewerten und die weiteren Schritte planen.				3b		Autoimmunerkrankungen, Essstörungen, Leukämie, Diabetes mellitus, Infektionskrankheiten, Atherosklerose der A. carotis (OPG), Tumore im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich und angrenzender Strukturen, Reflux, Schmerzstörung, affektive Störung	5; 6; 7; 9; 11; 19; 20; 21; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		
25.1.1.9	wichtige relevante Allgemeinerkrankungen oder Zustände, die einen Einfluss auf die zahnärztliche Therapie haben, nennen und die deren Zusammenhänge erläutern.				2		Unverträglichkeiten und Allergien, Erkrankungen, die mit einem erhöhten Bakteriämierisiko oder einer erhöhten Blutungsneigung einhergehen, Abhängigkeitssyndrome (Rauchen, Alkohol, N-Methylamphetamin), somatoforme Störungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Münchhausen-Syndrom; Zahnbehandlungs- und Blut-Spritzen-Verletzungsphobien, Panikstörungen	5; 6; 7; 9; 11; 14; 19; 20; 22; 23a; 23b; 23c; 23d; 23e; 23f; 23g; 23h; 26		